



FACULTAD DE EDUCACIÓN INFANTIL
DEPARTAMENTO DOCENTE DE EDUCACIÓN ESPECIAL
CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN LOGOPEDIA

TRABAJO DE DIPLOMA

ORIENTACIÓN FAMILIAR PARA LA PREVENCIÓN DE LAS DISFONÍAS INFANTILES

Autora: Laura Duque Wong

Tutora: Dr. C. María Mercedes Arredondo Kassabb

Profesor Titular

LA HABANA

2021

“El pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos, en la instrucción del pensamiento, y en la dirección de los sentimientos. (...) Un pueblo instruido será siempre fuerte y libre.”

José Martí

AGRADECIMIENTOS

A mi madre y a mi padrastro por el sacrificio que han realizado por verme graduada.

A mi incondicional hermana por ser mi otra mitad y acompañarme siempre.

A mis amigas de la carrera desde primer año por siempre estar presentes en mi formación.

A Gaby mi amiga y gran maestra de primaria por siempre alegrarme los días y darme fuerzas para seguir adelante.

A mi tutora la Doctora en Ciencias María Mercedes Arredondo Kassabb por su paciencia y apoyo durante la investigación.

Al colectivo de excelentes profesores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”, que me recibieron con gran aprecio cuando realicé el cambio de carrera y me enseñaron a amar mi profesión. Especialmente a Deysi, Delisel, Celia, Caridad Hernández, Armando, Diana Rosa y Regla, por brindarme las herramientas esenciales para ser una gran Logopeda.

A los docentes, los niños y las familias del círculo infantil “Los Habaneritos” en Bejucal, por abrirme las puertas y permitirme realizar mi investigación.

A todos aquellos que no he nombrado pero que siempre me han brindado su cariño, apoyo y preocupación.

¡Muchas Gracias!

DEDICATORIA

- ✕ *A mi mamá, por ser la fuente de inspiración y apoyo incondicional...*
- ✕ *A mi familia..., en especial a mi hermana Leticia por acompañarme siempre y por su paciencia...*
- ✕ *A mi tía Esperanza por siempre elogiarme y darme fuerzas para seguir.*
- ✕ *A mi padre y abuelos que desde lejos me protegen.*
- ✕ *A los educandos del círculo infantil, sus educadoras y familias.*

RESUMEN

Durante las primeras edades del niño, la función educativa adquiere una singular importancia, lo que justifica la necesidad de que se encuentre bien orientada para en el hogar, cumplirla de forma adecuada. La familia desempeña un destacado papel en la vida de cada persona, en su seno se sistematizan las experiencias educativas positivas, las relaciones interpersonales, convivencias, costumbres, identidad, entre otros valores que hacen que la familia sea la semilla de la sociedad. La investigación se realizó con el objetivo de ofrecer a las familias un manual de orientación para la prevención de las disfonías infantiles, en niños que asisten al círculo infantil “Los Habaneritos”, del municipio de Bejucal, de la provincia Mayabeque. Durante el proceso investigativo se utilizaron métodos del nivel teórico, empírico y estadístico matemáticos; que con los datos obtenidos se determinaron fortalezas y debilidades relacionadas con la orientación para prevenir la disfonía infantil y a partir de ellas, se elaboró el manual.

ABSTRACT

During the early ages of the child, the educational function acquires a special significance, which justifies the need is highly targeted to home, carry it properly. The family plays a prominent role in the life to each person, within it positive educational experiences, interpersonal relationships, coexistence, customs, identity, among other values that make the family the seed of society are systematized. The investigation was carried out with the aim of offering families an orientation manual for the prevention of childhood dysphonia in children in the children's circle “The Habaneritos”, in the municipality of Bejucal, in the Mayabeque province. During the research process the methods theoretical, empirical and mathematical statistical level were used; with data obtained strengths and needs related to prevent childhood dysphonia were determined and from them, the manual was prepared.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: REFERENTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS QUE SUSTENTAN LA ORIENTACIÓN FAMILIAR PARA LA PREVENCIÓN DE LAS DISFONÍAS INFANTILES	7
1.1.- Consideraciones generales acerca de la orientación familiar	7
1.2.- La prevención de la disfonía infantil como trastorno de la voz	12
1.3.- El papel del maestro logopeda en la orientación a la familia para la prevención de la disfonía infantil	18
CAPÍTULO II: MANUAL DE ORIENTACIÓN FAMILIAR PARA LA PREVENCIÓN DE LA DISFONÍA INFANTIL	21
2.1-Operacionalización de la variable y sus indicadores	21
2.2 Caracterización del estado inicial	22
2.3 Presentación de la propuesta. Características y estructura	26
2.3.1 Estructura del manual	29
2.4 Valoración de la propuesta	31
Conclusiones.....	33
Recomendaciones.....	34
Bibliografía	-
Anexos	-

INTRODUCCIÓN

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Es en ella donde el sujeto da los primeros pasos. Estos son firmes, cargados de afecto, voluntad, exigencias, ejemplos positivos, que permite al sujeto, la posibilidad de tener una personalidad más equilibrada y feliz. Si por el contrario adolece de estas condiciones, puede presentar dificultades en su formación. La familia es la que garantiza al niño la satisfacción de las necesidades materiales y afectivas.

A nivel social se reconoce, la necesidad de estrechar los vínculos entre la familia, la escuela y la comunidad. La gran responsabilidad que adquiere la primera con la educación de sus hijos; la segunda en prepararla para juntos educar a las nuevas generaciones y la tercera para sentar los valores sociales y de convivencia con los otros, en el barrio con sus códigos, costumbre y tradiciones que la identifican. Sociólogos, psicólogos, pedagogos; entre otros, se han interesado en la familia, como objeto de estudio de sus investigaciones. Internacionalmente se destacan las realizadas por la psicoanalista Schorn, M. N. (2008) quien revela aspectos significativos de la realidad de la familia.

Desde las actividades y las relaciones de la vida familiar se produce, gradualmente, la formación y transformación de la personalidad de cada individuo, lo cual quiere decir que, las relaciones de familia, tienen como característica proporcionar a los niños sus primeras cualidades de personalidad y de transmitirles los primeros conocimientos para su vida como ser individual y, a la vez, como ser social.

Durante todo este proceso, la comunicación desempeña las funciones principales, tanto informativas como afectivas, garantizando el acceso al mundo social y constituyendo una herramienta fundamental para la adquisición de nuevos conocimientos. Por ello es de vital importancia la estimulación y prevención temprana por los diferentes miembros de la familia, especialmente en el caso de familias con niños que presentan disfonía infantil, uno de los trastornos sutiles en edades temprana y que avizoran dificultades en la posterior vida adulta, cuya principal característica es la ronquera, gritos excesivos, ausencias parciales de la voz entre otras sintomatologías.

En Cuba se destacan los trabajos de investigadores como Castro, P L (1996, 2005), quien aborda la composición, características y funciones de la familia. Además, los aportes realizados por el Grupo de Familia de la Universidad de La Habana, liderado por la Dra. Arés, M.P (2002) así; como el folleto de orientación a la familia para niños con retraso del lenguaje de 3 a 6 años “Un futuro sin barreras” de la autora Ms. Rodríguez, A, M (2007) entre otros.

Uno de los propósitos del estado socialista cubano es la educación integral y armónica de la personalidad del hombre nuevo. Teniendo en cuenta dicho objetivo, el actual Programa Educa a tu Hijo realiza la educación familiar, dada por el tratamiento individualizado y sistemático de los problemas que presentan los padres para educar correctamente a sus hijos. Marcan pautas, considerando como elemento importante la iniciativa, la creatividad y la variabilidad de estos para su éxito y el tratamiento metodológico que se debe seguir en el trabajo educativo, principalmente en el cuidado de la salud física y mental de sus hijos y la voz como calidad vocal.

No obstante, en el ámbito clínico y educativo cabe destacar los estudios recientes realizados por Fletcher que han demostrado que el cuidado de la voz es menos significativo en personas que presentan disfonías funcionales y como el cuidado de la voz es un elemento esencial en la prevención y tratamiento de las afecciones de la misma, también se reconocen estudios realizados por autores nacionales e internacionales como, Bustos I. (1998), Gassull C, (2000), Fletcher HM (2001), Vasilenko Lus. (2005), Pozo, Quintana. T. (2006), así como colectivos de autores del MINSAP, entre otros especialistas, encaminados al cuidado y uso de la voz en diferentes profesiones y en el niño.

Los estudios antes referidos confirman la importancia de la orientación a la familia para acompañar a la escuela, la comunidad y centros de rehabilitación en el desarrollo de sus hijos, sin embargo, aún resultan insuficientes los que orientan para prevenir las disfonías infantiles, así como la bibliografía. A partir de entrevistas a especialistas, observaciones y por la labor investigativa de la autora, en el círculo infantil “Los Habaneritos”, del municipio de Bejucal, de la provincia Mayabeque, se pudo constatar cómo **situación problemática:**

- Escasa bibliografía en el círculo sobre la disfonía infantil como trastorno de la voz.

- Mal uso y modelos inadecuados de la voz desde la primera infancia por parte de los educandos, familiares y docentes en el hogar, la institución, y la comunidad.
- Insuficiente aprovechamiento de las potencialidades que brinda el maestro logopeda para contribuir a la orientación de las familias para la prevención de los trastornos de la voz.

A partir de lo anteriormente expuesto se identifica el siguiente **problema científico**:
¿Cómo contribuir a la orientación familiar para la prevención de la disfonía infantil en niños del círculo infantil “Los Habaneritos” del municipio de Bejucal?

En tal sentido, se enuncia como **Objetivo general**: Proponer un manual de orientación familiar para la prevención de la disfonía infantil en los niños, que asisten al círculo infantil “Los Habaneritos”, del municipio de Bejucal, de la provincia Mayabeque.

Para dar respuesta al problema científico de investigación, se determinan las siguientes **preguntas científicas**:

1. ¿Qué referentes teóricos- metodológicos sustentan el proceso de orientación familiar para la prevención de la disfonía infantil?
2. ¿Cuál es el estado inicial de la orientación familiar para la prevención de la disfonía infantil en niños del círculo infantil “Los Habaneritos” del municipio de Bejucal?
3. ¿Qué particularidades debe poseer un manual que contribuya a la orientación familiar para la prevención de la disfonía infantil de sus hijos que asisten al CI “Los Habaneritos” del municipio de Bejucal?
4. ¿Qué resultados se obtienen con la aplicación en la práctica educativa de la propuesta de solución al problema planteado?

Derivadas de estas interrogantes se desarrollaron las siguientes **tareas de investigación**:

1. Determinación de los referentes teórico - metodológicos que sustentan el desarrollo de la orientación familiar para la prevención de la disfonía infantil.

2. Diagnóstico del estado inicial de orientación familiar para la prevención de la disfonía infantil en niños del círculo infantil “Los Habaneritos” del municipio de Bejucal.

3. Elaboración del manual que contribuya a la orientación familiar para la prevención de la disfonía infantil en los niños que asisten al CI “Los Habaneritos” del municipio de Bejucal.

4. Valoración de los resultados obtenidos con la aplicación en la práctica educativa de la propuesta planteado por criterio de especialistas.

Los procedimientos metodológicos de la investigación tienen su base en el método dialéctico - materialista del Marxismo-Leninismo, como metodología general, lo que dio lugar a una propuesta flexible, susceptible de comprobación científica.

Se aplicaron, además, métodos de investigación a través de los cuales, se pudo obtener información sobre el problema identificado.

Del nivel teórico:

Analítico - Sintético: en la revisión y búsqueda bibliográfica consultada sobre la temática, para llegar al estado deseado, según lo expresado por la ciencia sobre el problema científico y el objeto de estudio, para el procesamiento de la información copiada por medio de los instrumentos diseñados.

Inductivo - Deductivo: se utilizó durante toda la investigación con énfasis en las consultas de fuentes y documentos, además para hacer generalizaciones lógicas de toda la información empírica sobre el objeto de investigación.

Modelación: permitió conformar un manual de orientación familiar para la prevención de la disfonía infantil.

El sistémico estructural funcional: utilizado durante toda la investigación y particular en la elaboración de la propuesta para la determinación de su estructura, funcionamiento y las relaciones entre las partes de las que consta.

Del nivel empírico:

Análisis documental: se analizó la caracterización psicopedagógica del grupo de educandos seleccionados para obtener datos relacionados con el área de la

comunicación, el lenguaje y la voz, al igual que constatar aspectos sobre la orientación a las familias, la prevención y las disfonías infantiles.

Observación: se empleó con el objetivo de observar la conducta y el uso de la voz de los educandos, sus familiares y las educadoras, durante las actividades de juego, las relaciones entre educadora- educando y familia-educando, lo que permitió obtener información acerca del objeto investigado.

Entrevista: a las especialistas y a la familia con el propósito de constatar el conocimiento acerca de la disfonía infantil y la orientación que poseen y ofrecen para su prevención.

Encuesta: a los docentes permitió la obtención de información relacionada con el tema que se investiga y a las familias para identificar las regularidades en relación con la orientación familiar en la prevención de la disfonía infantil.

Técnica de exploración logopédica: permitió diagnosticar a los educandos del grupo de estudio.

Consulta a Especialista: permitió evaluar los indicadores y la propuesta.

Del nivel matemático estadístico:

Análisis porcentual: en la realización del análisis cuantitativo sobre el resultado de los instrumentos realizados.

Atendiendo a los fines de la investigación se seleccionaron como **grupo de estudio** los siguientes:

Primer grupo- cinco familias del Municipio de Bejucal de la provincia Mayabeque

Segundo grupo- cinco educandos entre el quinto y sexto año de vida que asisten al círculo infantil “Los Habaneritos”.

Tercer grupo: tres docentes y dos directivos con experiencia, una promotora del Programa Educa a tu Hijo, cuatro agentes comunitarios.

Esta investigación es de la actualidad pues uno de los problemas que se observan en los centros educacionales es la insuficiente orientación a la familia para prevenir las disfonías infantiles. Por lo tanto, este manual contribuirá a la importante tarea de

profilaxis que deben realizar los docentes y los familiares para evitar este trastorno de la voz.

Dicho trabajo tributa a la Cátedra de Estudios Logopédicos “Ricardo Cabanas Comas” al proyecto "Buenas prácticas socioeducativas comunitarias para el desarrollo de la comunicación y el lenguaje en niños, adolescentes, jóvenes y adultos", del grupo científico Comunidad, Desarrollo Local, ambos dirigidos por la Dr. María Mercedes Arredondo Kassabb.

La investigación consta de introducción, capítulo I: donde se analizan los referentes teórico-metodológicos que sustentan la orientación familiar para prevenir la disfonía infantil en los niños que asisten al círculo infantil. El capítulo II que incluye la operacionalización de la variable de la investigación, el diagnóstico del estado actual a partir de la aplicación de los instrumentos, al igual que un manual de orientación para dar respuesta al problema de investigación. Precisa las conclusiones, recomendaciones; la bibliografía consultada y los anexos.

Dicha investigación ha sido presentada en preparaciones metodológicas de la escuela primaria Viet Nam Heroico del municipio de Bejucal, Mayabeque. Debido a la situación que atravesó el país por el COVID-19 no se pudo divulgar en otros lugares presenciales, pero si se presentó en eventos y conferencias online.

CAPÍTULO I: REFERENTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS QUE SUSTENTAN LA ORIENTACIÓN FAMILIAR PARA LA PREVENCIÓN DE LAS DISFONÍAS INFANTILES

En el capítulo se tratan los referentes teórico-metodológicos que sustentan la orientación familiar en la prevención de la disfonía infantil en educandos de quinto y sexto año de vida como una tarea profiláctica.

1.1.- Consideraciones generales acerca de la orientación familiar

El Dr. C. Alegret, P. L (2005), plantea que los momentos actuales son testigos de profundas transformaciones en el sistema de valores, como resultante de las condiciones económicas vigentes. La familia, aunque categoría psicológica, también lo es histórica y social. Ella es susceptible a los impactos y eventos significativos que se producen en la sociedad en el orden económico y sociopolítico. Todos estos procesos han trascendido y han acentuado la diversidad familiar en su estructura, pero fundamentalmente en su dinámica y su estilo de vida.

Existen diversos criterios en relación con la familia, entre los que encontramos en el libro del Dr. C. Alegret, P.L. Familia. (2002). La familia como institución social, como construcción interactiva de componentes individuales, representada en sus miembros, con su historia de origen y su propia psicología, es esencialmente expresión de una rica diversidad biológica, genealógica, cultural y social.

También en el libro de Perea, T. B. Escuela de Educación Familiar Para la Vida. La Habana: Pueblo y Educación, criterio por el cual la investigadora se afilia, plantea que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Sin familia no hay sociedad. Es en ella donde el sujeto da los primeros pasos; si estos son firmes, cargados de afecto, voluntad, exigencias, ejemplos positivos, entonces tiene la posibilidad de tener una personalidad más equilibrada y feliz. Si por el contrario adolece de estas características, puede presentar dificultades en su formación.

Para el trabajo con las familias es sumamente importante conocer las diferentes vías mediante las cuales se puede llegar a ellas y cambiar de cierta manera sus modos de actuar incorrectos. Las vías de educación familiar son las acciones, los modos de

preparar, interactuar y capacitar a las familias para un desempeño más efectivo, para lograr el cumplimiento de sus funciones y los procesos de transformación que reclama el desarrollo de sus miembros y de la sociedad. Vías a utilizar en la estrategia de interacción con la familia.

Vías directas

La conversación que se produce al dejar y recoger los padres al niño en la institución infantil.

- Las escuelas de educación familiar.
- Las sesiones de consulta familiar (consultas psicopedagógicas).
- Las reuniones de padres.
- Entrevistas de orientación a la familia.
- Las visitas al hogar.
- Actividades escolares conjuntas padres–hijos.
- La dinámica de grupos familiares.

Vías indirectas

- Recomendaciones de lecturas para los padres.
- Mensajes a las familias, mediante cartas.
- Los murales de orientación a la familia.
- El trabajo con los niños.

Todas las vías de educación familiar deben tener una adecuada organización, planificación, ejecución, control y evaluación. Esto es lo que garantiza el éxito, el logro de los objetivos previstos en la orientación de las familias para cumplir con sus funciones y alcanzar un desempeño más efectivo, logrando los procesos de transformación que reclama el desarrollo de sus miembros y de la sociedad.

En el libro, Autores, C. d. (2009). Herramientas Básicas para el trabajo con la familia, se brindan preguntas para comenzar una correcta orientación a la familia y para ello es sumamente importante conocer:

¿Qué objetivos tienen las familias? ¿Cuáles son las perspectivas o proyectos para con la educación de sus hijos? ¿Muestran interés por su aprendizaje y desarrollo?

¿Acuden a la escuela a informarse sobre el desempeño de sus hijos? ¿Están en condiciones de ayudarles en el aprendizaje y en general en el proceso educativo?

¿En qué condiciones viven los educandos? ¿Qué ambiente educativo existe en los hogares?, ¿Qué métodos educativos se emplean? ¿Qué y cuánto podemos hacer por transformar positivamente las influencias educativas del hogar? ¿Qué considera la familia anda bien y qué debe cambiar en la educación de sus hijos? ¿Qué proponen?

Se debe esclarecer cuáles son las principales capacidades y habilidades profesionales que se desarrollan y se ponen a prueba en el trabajo con las familias de los escolares.

Desde la posición del Dr. C. Alegret, P. L (2003), nos brinda lo común de toda familia cubana de hoy, y para ello se puede destacar:

- ✓ Carácter abierto. Se revela en su continua interacción con el entorno, lo que es facilitado por la propia estructura y organización a nivel macro social y el carácter comunicativo del cubano, que siempre está dispuesto a recibir y a dar, aunque no siempre esa comunicación fluya con un sentido de interacción necesario. Las organizaciones, los centros educacionales, culturales, de salud y otros servicios a nivel de barrio, movilizan permanentemente el intercambio con la familia, la que como expresara P. Arés con sentido humorístico, "es tanta la compañía que a veces quisiera un poco de soledad.
- ✓ Dinámica. El carácter activo, ágil y operativo es otro de los atributos que caracteriza la familia cubana. La búsqueda inmediata de soluciones a tareas y problemas es una de sus grandes fortalezas, aunque no siempre sus procedimientos y resultados sean los más efectivos, por cierta tendencia a la impulsividad con poca utilización de la persuasión. Asume rápidamente los cambios y con esa misma agilidad se reorganiza, matizado por su locuacidad, lo que constituye una fuerza motriz, que le ayuda a enfrentar la cotidianidad, los momentos de crisis, y mantener la salud familiar.
- ✓ Alegre, optimista y cálida. Muchos extranjeros que nos visitan identifican al cubano por esa contagiosa alegría, el disfrute de lo bueno de la vida. Aun en los momentos más difíciles, esa sonrisa siempre a flor de labios, que expresa con la frecuente broma y su rico sentido del humor, lo que ha sido calificada por muchos, como uno de los grandes valores de esta isla. Quizás este

constituye uno de los principales recursos protectores de nuestras familias, que las hace resistir, vencer y levantarse ante los eventos más impactantes y estresantes.

- ✓ Solidaria. La familia cubana ha desarrollado por tradición histórica nacional, que ha trascendido las fronteras de los hogares, una práctica de la solidaridad humana, desde dentro y hacia fuera. Es frecuente encontrar que en situaciones de discordias familiares cuando un miembro está en apuros, todos se sienten comprometidos con la ayuda y en ese momento olvidan sus desavenencias.
- ✓ Sobreprotectora. Hay una tendencia a prolongar la dependencia de los hijos. Con excepción de familias muy desorganizadas, en general los niños no tienen todas las oportunidades de participación que necesitan, en las tareas y responsabilidades del hogar. Se considera que es responsabilidad de los adultos, que es peligroso para el niño o no sabe, puede romper y utilizar mucho tiempo, “ya tendrá tiempo para hacerlo, su tarea es jugar y estudiar”, piensan y dicen muchos padres. Por otra parte, hay un temor excesivo al contagio de influencias negativas y a supuestos peligros físicos y psíquicos, lo que lleva a limitar y reducir los espacios de acción y la autonomía con otros niños.
- ✓ Motivada por el aprendizaje. Aunque no todas las familias en Cuba se desempeñan de forma desarrolladora, en general han formado una fuerte motivación por el aprendizaje y se afanan en que los hijos aprendan, aunque no siempre los métodos que utilicen sean los más efectivos. El propio proyecto social cubano, ha propiciado el desarrollo de elevadas expectativas hacia el nivel cultural y académico en la población. Constituye una meta a lograr en todas las familias, que sus hijos hagan una carrera técnica o universitaria.

Las instituciones educativas, los docentes y en particular los maestros logopedas encuentran en la familia un terreno propicio para el cumplimiento de su función orientadora y de esta forma contribuyen al desarrollo del desempeño familiar exitoso. La educación y orientación o preparación para la vida consiste en la preparación concreta y precisa para hacerle frente a una edad y a una época o circunstancia histórica social determinadas.

Como movimiento, la Orientación Educativa surgió a inicios del siglo XX en los Estados Unidos, a partir de los trabajos de T. Parsons, B. Davis y E. L. Kelly. En sus inicios la orientación estuvo muy marcada por lo vocacional, tan es así que sus límites

no estaban muy precisos, comenzando en los años 20 del siglo XX un proceso de tránsito hacia el modelo clínico.

La orientación estará determinada por una interacción entre los propósitos previos de transmisión y formación de cultura (entiéndase aquí conocimientos, valores, habilidades, motivos) plasmados en programas de enseñanza, y las particularidades que nos van revelando los grupos y sujetos. Aunque incluye y necesita la planificación, la orientación, como la educación en general, no puede ser un proceso rígidamente concebido sino un proceso devenido y construido en un quehacer cotidiano que debe ser constantemente revisado, cuestionado y reconstruido, partiendo de un diagnóstico sistemático de la realidad y desde una actitud crítica frente a la misma.

Por su parte Vélaz de Medrano Ureta C. (2002) definió la orientación como: “conjunto de conocimientos, metodologías y principios teóricos que fundamentan la planificación, diseño, aplicación y evaluación de la intervención psicopedagógica preventiva, comprensiva, sistémica y continuada que se dirige a las personas, las instituciones y el contexto comunitario, con el objetivo de facilitar y promover el desarrollo integral de los sujetos a lo largo de las distintas etapas evolutivas de su vida, con la implicación de los diferentes agentes educativos (orientadores, tutores, profesores, familia) y sociales”.

La autora considera que la definición dada por Rodríguez Espinar S. y colaboradores (1993) no se ajusta en su totalidad a la realidad cubana actual, ya que el servicio y la práctica profesional tienen un carácter psicoterapéutico, según los trabajos desarrollados por F. Zaldívar Pérez D. (1999). Sin embargo, considera que la concepción que más se ajusta es la planteada por Vélaz de Medrano Ureta C. (2002).

Es por ello que la autora asume la orientación a la familia [...] como un proceso de ayuda para el mejoramiento del funcionamiento familiar a partir de la interacción e integración de los miembros de la familia, la escuela y el contexto comunitario de que forma parte, lo que propicia la transformación del rol de cada uno en particular, sobre la base del reconocimiento de las necesidades que en ellas se manifiesten, que permita elevar su preparación psicológica, pedagógica y comunicacional para el mejor desempeño del ejercicio de sus funciones educativas en los escolares. (Téllez V. O pp. 226-236, 2018).

Se concuerda con esta autora porque coloca al proceso de ayuda como interacción e integración de los miembros a partir del rol de cada uno para elevar su preparación y tener un mejor desempeño en su función educativa en los escolares.

La orientación a la familia debe estar dirigida hacia todos los sectores y ámbitos, incluso hasta el cuidado de la voz. Para prevenir que las familias les enseñen a sus hijos patrones lingüísticos incorrectos y estén atentos ante cualquier signo de alerta de un posible trastorno de la voz.

1.2.- La prevención de la disfonía infantil como trastorno de la voz

La prevención como un resultado genuino y propio de una labor docente educativa de calidad, implica que se cumpla con los aspectos conceptuales, metodológico y prácticos de este tipo de trabajo que han de realizar, funcionarios del Ministerio de Educación, metodólogos, inspectores, directivos de escuelas, maestros y profesores del Sistema Nacional de Educación, en estrecha relación con la familia y la comunidad.

Bell (2002) en el libro *Prevención y Educación Preescolar*, se refiere a la prevención como un sistema de influencias que en el ámbito educativo ha de anticiparse a las posibles dificultades que en el proceso puedan surgir exigiendo la atención oportuna de las necesidades educativas, que los niños presentan dentro del ámbito educativo general.

El término prevención es una categoría que al ponerse en práctica adopta objetivos estratégicos específicos. En esencia, como concepto se refiere a evitar o disminuir las consecuencias del efecto de un factor causal conocido total o parcialmente. Lantigua, Aracely (2003)

Prevención significa, además, *prepararse y disponer de lo necesario, con anticipación, para alcanzar un fin; es actuar para que un problema no aparezca, es adelantarse de forma creativa*; Travieso, Eulalia (2008) concepto que la autora asume por tratarse de poder dar seguimiento a los factores desencadenantes que se producen por una inadecuada praxis en el uso de la voz desde la primera infancia y que los padres no avizoran a tiempo y desencadenan en causas más complejas como la disfonía.

La prevención se concibe en la actualidad como un abordaje que incluye todas las ciencias y los diferentes sectores de la sociedad. El fin está claro, debe haber una

articulación del conocimiento entre todos. Ahora el enfoque más que dirigido a factores de riesgo se enfatiza en el fortalecimiento de factores de desarrollo en un proyecto de vida.

Debe verse como un hecho humano, fundamentar sus acciones en las personas y la sociedad, más que en las sustancias, se debe ir a la raíz del problema, implica revisar el rol de los procesos socializadores de la familia, la escuela y la comunidad donde se ha producido un vacío. Esta es un proceso educativo que pone su acento en la instrumentación para la vida.

Ha de seguir lo planteado por Vigotski respecto a que el período de mayor plasticidad del sistema nervioso y más sensitivo para el desarrollo general del niño es el comprendido entre 0 y 5 años. Al reflexionar sobre estas palabras y en relación con el binomio plasticidad- vulnerabilidad y el contenido de la estimulación temprana, es necesario tener en cuenta las categorías sociales, biológicas y psicológicas en que el niño se ha desarrollado. Es por ello, como un nivel de comunicación que la voz debe preverse, sus efectos nocivos que en la población mundial está aconteciendo con los resultados de la pandemia COVID -19 en pacientes entubados y otros que por causas psicológicas se les afecta este órgano fonatorio con incidencia además en la población infantil de la primera infancia.

La voz ha sido objeto de estudio por muchas ciencias, disciplinas y ramas del saber humano, es por ello que existen múltiples definiciones entre las que se destacan según el Dr. Cabanas, R. en el libro Logopedia, Parte 2, define que la voz [...] es toda emisión de sonido producido por el órgano laríngeo. Es el fondo musical de las palabras, cuyo valor como elemento comunicativo, es de carácter afectivo que traduce los sentimientos.

Para que la familia, en especial los padres, sepan de la importancia de conocer ¿Qué es un trastorno de la voz?, se toma en consideración referencia para explicar en qué consiste, a través del concepto que brinda el Dr. Cabanas, R, [...] se entiende toda perturbación de la voz que afecte cualquiera de sus tres cualidades: tono, timbre e intensidad. La voz se percibe como alterada cuando su calidad tímbrica es diferente a la habitual, generalmente más oscura, mate, rasposa, velada; o cuando contrasta por sus características, respecto a las voces de otras personas de la misma edad y sexo, aunque sea la voz que ha utilizado toda la vida.

- ✓ Tono o altura: Dado por el número de vibraciones de las cuerdas vocales que se producen en el tiempo, pues por lo que está muy relacionado con la frecuencia de la onda sonora, mayor vibración: agudo, menor vibración: grave. En los hombres las cuerdas vocales son más finas, más largas y más fuertes y en las mujeres y niños las cuerdas vocales son más graves, más cortas y más débiles.
- ✓ Timbre: Resultado de la combinación de un sonido fundamental con los complementarios, interfiere la laringe, puede ser nasal, vivaz, estridente, chillón, monótono, pobre en armónicos.
- ✓ La Intensidad: Fuerza del sonido que está en relación con la amplitud de las ondas sonoras, dependerá de la columna de aire espirado, puede ser fuerte, media o débil.

Conociendo que es un trastorno de voz, la autora hará referencia a un tipo de este trastorno, las disfonías, donde revelará los diferentes conceptos, causas y sus características más frecuentes. Se reconoce el concepto dado por Arias, C.E(2005) al cual la autora se afilia, que lo define como un ...*"Trastorno que altera una o varias características acústicas de la voz o cualquiera de las fases de la función de los elementos que intervienen en su producción cuya finalidad última es la expresión y la comunicación verbal"*.

Según el texto del Módulo1, Promoción y Prevención de Salud, definen Disfonía como: el trastorno del timbre de la voz, llamadas también “ronqueras”, causadas por afecciones a nivel laríngeas o extralaríngeas, ya sean orgánicas como parálisis recurrencial, tumoraciones, malformaciones congénitas, o funcionales por mal uso y abuso de la voz. Se presentan con mucha frecuencia en nuestro medio principalmente en la infancia, en los profesionales de la voz y en fumadores.

Las disfonías surgen debido a varias causas, entre las que se encuentran las orgánicas y funcionales.

Disfonías funcionales: Se debe a un mal uso y abuso de la voz por empleo incorrecto de un tono, modulación, timbre, intensidad, apoyo respiratorio, ya sean aislados o concurriendo todos estos factores.

Se evidencian otros tipos de disfonías funcionales como:

- Disfonía psíquica: Se puede presentar como una disfonía o afonía de comienzo brusco que puede desaparecer sin tratamiento.
- Disfonía audiógena: Se produce por problemas en la audición, en ocasiones pequeñas pérdidas en los tonos agudos que impiden el exacto control auditivo de la propia voz.

Disfonías orgánicas: pueden ser ocasionadas por infecciones respiratorias agudas que no guardaron el agudo reposo vocal, laringitis infecciosas no curadas, procesos alérgicos no controlados e infecciones de la faringe y estomatológicas que son factores favorecedores de la patología vocal.

En ella se puede encontrar: Las hiperemias o enrojecimientos de las cuerdas vocales que determinan una laringitis aguda, los nódulos, los pólipos, la úlcera de contacto, la papilomatosis.

En el libro de Madueño, M. A. Logopedia y Formación. Buenos Aires ,2019 (Argentina), se plantea que la disfonía infantil es un diagnóstico frecuente en la práctica logopédica, generado en su gran mayoría a partir del uso incorrecto de la voz o el abuso de la misma. Estas alteraciones laríngeas en los niños son cuadros benignos que responden satisfactoriamente al entrenamiento vocal (logopedia). En líneas generales, son pacientes que llegan a la consulta por derivación del pediatra, del otorrinolaringólogo (ORL) o de la escuela, donde el trastorno vocal que padecen los educandos en clase se hace evidente.

Las disfonías infantiles son trastornos de la voz que afectan a niños y niñas en edades comprendidas entre los seis y 10 años hasta la edad puberal. Afectan a casi la mitad de los niños en edad escolar. Generalmente estos trastornos no son severos y no suelen suponer la pérdida completa de la voz de manera prolongada o permanente. Los factores que lo predisponen son niños hiperactivos, contexto familiar hiperactivo con padres ansiosos, comunicación por medio de gritos, padres disfónicos (imitación de patrones), tendencia del niño a presentar cuadros ORL (otitis, faringitis, entre otras patologías subyacente en la edad infantil), cirugías previas (adenoides, amígdalas, nódulos), deficiencias auditivas.

Aunque la causa funcional es la más asidua, algunas alteraciones vocales comienzan siendo funcionales y a través del tiempo se favorece la aparición de lesiones, debido a la continuidad del mal uso de la voz y en ausencia de un tratamiento logopédico.

Esta nueva situación modificará el diagnóstico que pasará de ser una disfonía funcional (sin lesión cordal) a una disfonía mixta u orgánico funcional, donde los nódulos vocales son el hallazgo laringológico más frecuente. Las disfonías infantiles suelen aparecer con ocasión de una alteración transitoria de la laringe (laringitis viral) durante la cual el niño no ha respetado la moderación vocal pertinente, otras veces tras una amigdalotomía, el niño puede verse obligado a un comportamiento de sobreesfuerzo vocal, y otras afectaciones.

Según diversos autores este trastorno tiene una incidencia entre el 70% y el 80% de los niños roncos presentan nódulos vocales. En cuanto al sexo la relación sería una niña por cada tres niños, siendo el pico de incidencia entre los 5 y los 10 años de edad aproximadamente. “Muchas veces el mecanismo de sobreesfuerzo vocal y sobrecarga funcional constante, puede provocar lesiones en las cuerdas vocales. Entre estos trastornos se puede considerar los nódulos vocales, con una incidencia en la población infantil entre el 50% y el 70% de casos, según diferentes estudios”. Pazo, Telma (2007).

- Las características vocales de estos niños son: voz ronca, áspera, aireada, golpes glóticos, respiración audible, fatiga vocal, incoordinación fono-respiro-articulatoria, y una extensión tonal acortada (4 o 5 tonos) y desplaza hacia los graves. Recordemos que toda disfonía es un síntoma, por lo tanto, en los niños una voz agravada (disfónica) se considera anormal o fuera de la norma, siendo su opuesto la voz aguda que sería un índice de normalidad, tanto en las niñas como en los niños.
- Cuando en los niños se observen ataques vocales bruscos, golpes de glotis, risas y llantos muy intensos, restricción mandibular en la articulación de la palabra, respiración torácica alta o clavicular, inspiración bucal, fonación invertida o inspirada, consumo de aire residual hablando hasta quedarse sin aliento, rigidez en el cuello, venas ingurgitadas, chillidos incontrolados, ritmos de habla incontrolados y rápidos, uso de tonos e intensidades desmedidas, vicios posturales y dientes apretados etc., se está en presencia de signos de alertas por disfonías que convocan al trabajo preventivo.

La voz para el niño es una forma de expresión emocional. El niño a través de su disfonía está expresando el mal uso que hace de su voz, manifiesta una inhabilidad

fonatoria, un sobreesfuerzo, una hiperfunción que afecta a la musculatura endolarígea y perilarígea, acciones que deberemos modificar en el transcurso de la reeducación. La importancia de la prevención, la educación y la higiene de la voz desde la niñez, evitarán el desarrollo de alteraciones de la voz y lesiones laríngeas con posibles repercusiones en su salud actual y futura.

El uso adecuado de su lenguaje y la expresión oral correcta son condiciones necesarias de los familiares. Como modelo lingüístico debe ser portador de una norma culta en todos los niveles de la comunicación oral referidos a lenguaje, habla y voz. El padre debe hacer uso de un lenguaje rico en vocabulario adecuado a la edad del menor y esto justamente se logra al ampliar siempre sus conocimientos mediante la lectura. Constituye este el más eficaz método preventivo.

Para prevenir los trastornos de la voz es necesario tener en cuenta la higiene vocal, se debe conocer los factores que intervienen en el acto vocal, para poder educar y potenciar el mecanismo de fonación, como así también, evitar el mal uso y el abuso del mismo. Existen algunas recomendaciones encaminadas fundamentalmente a prevenir y reducir las conductas abusivas de la voz ya que pueden ser de gran utilidad si contamos con la ayuda de los padres en los hogares. Estas son:

- ✓ No realizar esfuerzos vocales como gritos, llamados a voces durante el juego o el deporte, hablar sobre ruidos ambientales o musicales.
- ✓ Evitar ambientes contaminados por presencia de polvo, humo, cambios de temperaturas o condiciones atmosféricas desfavorables.
- ✓ No utilizar la voz durante procesos inflamatorios agudos del aparato fonador.
- ✓ Controlar las enfermedades de base, como procesos alérgicos respiratorios, otorrinolaringológicos'.
- ✓ El sueño como manifestación de reposo debe siempre respetarse, durmiendo de 6 a 8 horas y evitar el uso vocal en las primeras horas de levantarse.
- ✓ Eliminar el hábito de toser y aclarar excesivamente la garganta pues eso resulta irritante.
- ✓ En caso de aparecer constantemente tos, con situación febril, decaimiento, sequedad, acudir al médico por constituir estados de alertas de un tipo de virus entre ellos COVID-19.

Tanto el docente, las personas de la comunidad y el familiar están expuestos a un mal uso y abuso de la voz, cuando no hace un adecuado uso de los recursos decentes que le permiten economizar su voz y disminuir el esfuerzo vocal, no descansa la voz en los tiempos libres y con frecuencia se usa la misma como control disciplinario, todo lo cual determina un maltrato de su órgano vocal. El maestro logopeda debe orientar a la familia para que cuiden y eviten las agresiones del aparato vocal en sus hijos.

1.3.- El papel del maestro logopeda en la orientación a la familia para la prevención de la disfonía infantil

Las funciones del maestro logopeda constituyen la concreción de la esencia de su profesión, las que se manifiestan en su modo de actuación profesional. Las funciones profesionales pedagógicas declaradas por el Ministerio de Educación, son: función docente – metodológica, la función investigativa y de superación y la función de orientación.

La función orientadora, en la que diferentes especialistas discuten la posesión del ejercicio de la orientación. Así algunos consideran la orientación en el área de la psicología y separan la orientación psicológica que realiza el psicólogo como especialista de esta ciencia de la orientación pedagógica que puede, debe y tiene que realizar el maestro logopeda. Diferentes acciones tipifican a la orientación como función profesional pedagógica entre otras se puede citar: la orientación a la actividad de estudio, orientación profesional pedagógica, orientación pedagógica a la familia.

Estas acciones se pueden realizar de forma individual o grupal. Una orientación de calidad demanda del maestro logopeda la precisión del área de orientación y la búsqueda de información y la profundización en las teorías educativas que con ellas se relacionan, así como el diagnóstico del niño, la familia, la comunidad, en un proceso continuo de investigación que permite pronosticar, y proyectar acciones de orientación, por lo que se convierte en un hecho innegable la vinculación de la investigación educativa con la función orientadora del maestro logopeda.

La función orientadora consiste en que el maestro logopeda esté preparado para que pueda descubrir las esencias de los trastornos del lenguaje y la comunicación, discapacidades, limitaciones y las potencialidades de sus educandos. Brindar las ayudas que necesiten en cada momento del proceso preventivo, correctivo y desarrollador del lenguaje y la personalidad, de manera que estos puedan, de acuerdo con sus particularidades, perfeccionar el dominio de la lengua materna, de

las habilidades comunicativas, su autoestima, regular su conducta. Contribuir a la preservación y cuidado de su salud física y bienestar emocional y con ello, lograr la máxima integración social posible. El Programa Educa Tu Hijo (PETH) constituye un marco idóneo para el desarrollo de dicha orientación.

Si bien la orientación educativa ocurre, generalmente, cuando el sujeto está ante una situación problemática o conflicto que no ha podido resolver, su repercusión trasciende los límites de esas situaciones para posibilitar el crecimiento personal del sujeto. Las ayudas le preparan para la vida, a partir de la adquisición de estrategias y procedimientos eficaces de solución de problemas y conflictos, que le permiten su resolución y generan un bienestar emocional y con ello, la elevación de su calidad de vida, con un impacto positivo para su salud.

Es necesario que exista una adecuada comunicación entre el maestro logopeda y la familia. A continuación, se ofrecen algunos requerimientos para el éxito de la misma.

La familia necesita:

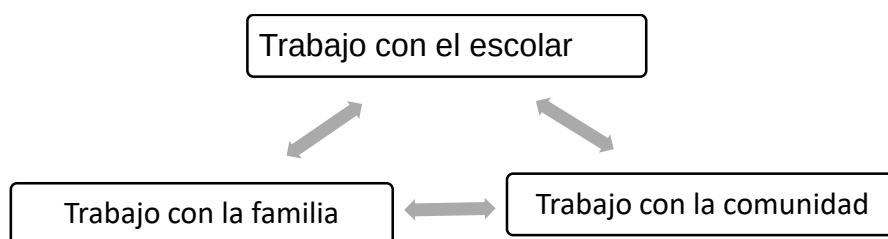
- ✓ Sentirse respetada.
- ✓ Ser escuchada.
- ✓ Un espacio de privacidad con el maestro logopeda.
- ✓ Sentir que se le quiere ayudar.
- ✓ Que se confía en ella.
- ✓ Que se reconocen sus aciertos.
- ✓ Que se reconocen más sus acciones positivas, que sus errores.
- ✓ Que se compartan sus preocupaciones, sus angustias.
- ✓ Que se le trasmita optimismo.

La atención logopédica comunitaria tiene un enfoque preventivo de inclusión social para la atención logopédica, en la diversidad de niños, adolescentes, jóvenes y adultos para un óptimo desempeño de las habilidades comunicativas y sociales en un entorno determinado con carácter intersectorial. Arredondo, M, M. (2005)

En la realización de la orientación familiar, desde la actividad profesional del logopeda, se impone tener en cuenta factores como el nivel cultural y socioeconómico de las familias, la preparación de los padres para cumplir con sus funciones y el desarrollo alcanzado por los niños/as. La orientación a las familias que residen en zonas rurales, además requiere tener en cuenta otros aspectos tales como:

dificultades financieras, alimentación, vivienda, transporte, comunicación familiar, electricidad, salud, problemas medioambientales y alto índice de alcoholismo, que tipifican la dinámica familiar.

Para la realización de un correcto trabajo preventivo se requiere del concurso del docente, de la familia, del niño y del esfuerzo del colectivo pedagógico en general, bajo la dirección del círculo infantil, del maestro logopeda, con mucha discreción, sensibilidad, tacto pedagógico y dedicación para que no se afecte la integridad de la familia. El trabajo preventivo es importante realizarlo en sus tres direcciones básicas para garantizar el éxito deseado, con el escolar, la familia y la comunidad (organizaciones, organismos e instituciones).



La etapa preescolar posee una alta significación para el desarrollo del individuo, en ella se instauran los fundamentos para la formación de su personalidad, lo que se logre hacer en ella, tiene una repercusión crucial para la vida del ser humano. Es la etapa más importante del individuo, donde la familia y el entorno social cobran un papel preponderante en el desarrollo físico, cognitivo y afectivo. En este período la familia debe recibir orientaciones constantemente.

CAPÍTULO II: MANUAL DE ORIENTACIÓN FAMILIAR PARA LA PREVENCIÓN DE LA DISFONÍA INFANTIL

En este capítulo se realiza la operacionalización de la variable, elaboración de los indicadores y el análisis de los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos, se fundamenta el manual de orientación familiar dirigido a la prevención de la disfonía infantil en educandos que asisten al círculo infantil “Los Habaneritos” del municipio de Bejucal de la provincia Mayabeque. También se presenta la estructura y funcionamiento de dicho manual, al igual que su valoración mediante el criterio de especialistas, como los resultados obtenidos con la aplicación de la propuesta en la práctica pedagógica.

2.1-Operacionalización de la variable y sus indicadores

Mediante las investigaciones realizadas acerca de las familiares, la comunidad y los docentes. Se constató, que son los responsables de fomentar el correcto cuidado de la voz para prevenir las disfonías, de ahí la importancia de poseer conocimientos sobre el tema.

El estudio teórico realizado acerca de la orientación familiar, a los autores Peña. N (2002), Torres. M (2010), G. (2005-2009), Gómez. A (2007), Bernal, R. (2010), Padrón, A.R. (2011), Áreas, G. (2011), Téllez, V. O. (2018), entre otros, los datos que aparecen sobre las disfonías infantiles a los autores, Núñez, E (1995), Bustos, I. (1999), Ares, N, P (2002), Gervilla, E (2003), Arias, C. E. (2005). Torres, M.V. (2010), Hernández, D, D (2017), entre otros, así como los resultados de la exploración en la práctica permitieron determinar cómo **variable de la investigación: la orientación familiar para la prevención de las disfonías infantiles. [...] como un proceso de ayuda para el mejoramiento del funcionamiento familiar a partir de la interacción e integración de los miembros de la familia, la escuela y el contexto comunitario** de que forma parte, lo que propicia la transformación del rol de cada uno en particular, sobre la base del reconocimiento de las necesidades que en ellas se manifiesten, que permita elevar su preparación **psicológica, pedagógica y comunicacional** para el mejor desempeño del ejercicio de sus funciones **educativas** en los escolares. (Téllez V. O pp. 226-236,2018), para la solución del problema de investigación que se define

como un proceso de ayuda encaminado a la orientación de los familiares para adoptar a tiempo medidas profilácticas contra la disfonía como un trastorno de la voz.

La definición anterior permitió identificar los indicadores, los cuales fueron sometidos a una valoración por especialistas en el tema para su conformación.

Indicadores para la orientación familiar

- Nivel de conocimiento del trastorno de la voz por las familias, educadores y comunidad.
- Nivel de orientación a la familia acerca de la prevención de la disfonía infantil.
- Estado en que se halla el modelo comunicativo en familias y docentes.

El diagnóstico del estado actual del problema que se investiga reveló que existen insuficiencias en la preparación de las familias para la prevención de las disfonías infantiles. También existe una escasa orientación por parte de los docentes a los familiares en cuanto a este importante tema y mediante la observación se detectó que el modelo comunicativo de los mismos, en ocasiones es el inadecuado.

2.2 Caracterización del estado inicial

Para la investigación se seleccionó el círculo infantil “Los Habaneritos” del municipio de Bejucal de la provincia de Mayabeque. Como primer grupo de estudio se eligió cinco familias, donde dos de ellas son disfuncionales y dos monoparentales; sus niveles de escolaridad varían entre 9no grado y el técnico medio en la mayoría, no todas son potenciadoras del desarrollo de los educandos y todas desconocen el trastorno de la voz.

El segundo grupo de estudio de educandos son tres de sexto año de vida y dos de quinto año de vida, donde sus edades varían de cuatro a cinco años, los cuales mediante la aplicación de técnicas y la observación se pudo constatar que presentan signos de alertas ante una disfonía infantil. Además, como tercer grupo se encuentran tres docentes y dos directivos con experiencia, una promotora del Programa Educa a tu Hijo y cuatro agentes comunitarios.

Observación participante (Anexo#1)

Se aplica a las familias en diferentes contextos como son el hogar, las reuniones de padres, las visitas al centro, etcétera. Estas observaciones fueron realizadas varias

veces en diferentes etapas con el objetivo de constatar el estado de orientación que posee la familia para contribuir la prevención de la disfonía infantil.

La valoración de los datos obtenidos como resultado de la aplicación de las observaciones realizadas permitió determinar:

- ✓ Las relaciones intrafamiliares no son las más adecuadas para los menores.
- ✓ Existen escasas expresiones de afecto entre los miembros de la familia.
- ✓ No se evidencia la participación del niño en la toma de decisiones en relación con la prevención de la disfonía infantil.
- ✓ Las familias no conocen que es la disfonía infantil, las características que presentan sus hijos y por lo general no le ofrecen tareas encaminadas a la prevención de este trastorno de la voz. 60%
- ✓ No se utilizan acciones derivadas de las vías de educación familiar para contribuir a la prevención de la disfonía infantil.
- ✓ La familia ignora éxitos y fracasos relacionados con la prevención de la disfonía infantil en sus hijos, por lo que asumen una actitud indolente ante la aparición de los mismos.

Entrevista a la familia: (Anexo#2)

La entrevista a la familia se aplicó con el objetivo de conocer su preparación sobre los trastornos de la voz.

- ✓ La familia desconoce las características del habla de su hijo, no identifican cualidades particulares de su voz y no le otorgan ninguna importancia a la disfonía infantil. 60%
- ✓ Desconocen la génesis de las particularidades de la voz de su hijo.
- ✓ No les prestan atención a las características particulares del habla del hijo.
- ✓ La familia no tiene conocimiento acerca de la prevención de la disfonía infantil, no existe conciencia de la presencia de la disfonía infantil de su hijo. 60%
- ✓ Presentan disposición para ofrecer ayuda a su hijo. 90%

Además, se analizan las preguntas incluidas durante el propio desarrollo de la entrevista.

- ✓ ¿Qué papel puede desempeñar la familia en la prevención de la disfonía infantil?

Consideraron que, si la familia es adecuadamente preparada, puede jugar un papel importante en la prevención de la disfonía infantil.

- ✓ ¿Qué vías de educación familiar le gustaría que se utilizaran para prepararla en la prevención de la disfonía infantil?

Para esta pregunta la familia necesitó niveles de ayuda, solo entonces logró exponer como vías, escuela de padres, murales informativos, reuniones de padres.

Entrevista a los docentes y directivos: (Anexo#3)

Se aplicó a las educadoras con el objetivo de constatar el estado de la orientación a la familia, para contribuir a la prevención de la disfonía infantil.

- ✓ Dos de las educadoras presentan nivel superior, poseen el título Licenciatura en Educación Preescolar, y una es graduada de técnico medio.
- ✓ Una de las educadoras, al igual que los tres directivos acumulan 10 años de experiencia, mientras que las otras dos educadoras acumulan menos de un año de experiencia pues son graduadas recientemente.
- ✓ Poseen un conocimiento limitado de las características de los niños con disfonías infantiles, asociado fundamentalmente a la cualidad tono. 70%
- ✓ Las educadoras no tienen en cuenta las medidas para prevenir la disfonía infantil.

Además, se analizan las preguntas incluidas durante el propio desarrollo de la entrevista

- ✓ ¿Quiénes le ayudan a realizar este trabajo?

Consideran que en este trabajo las puede ayudar la doctora, la jefa de ciclo, los maestros de experiencia y la maestra logopeda.

- ✓ ¿Qué disposición poseen para ofrecer respuestas a la prevención en los niños con diagnóstico de disfonías infantiles?

Declaran poseer una elevada disposición para participar en la prevención de la disfonía infantil 90%.

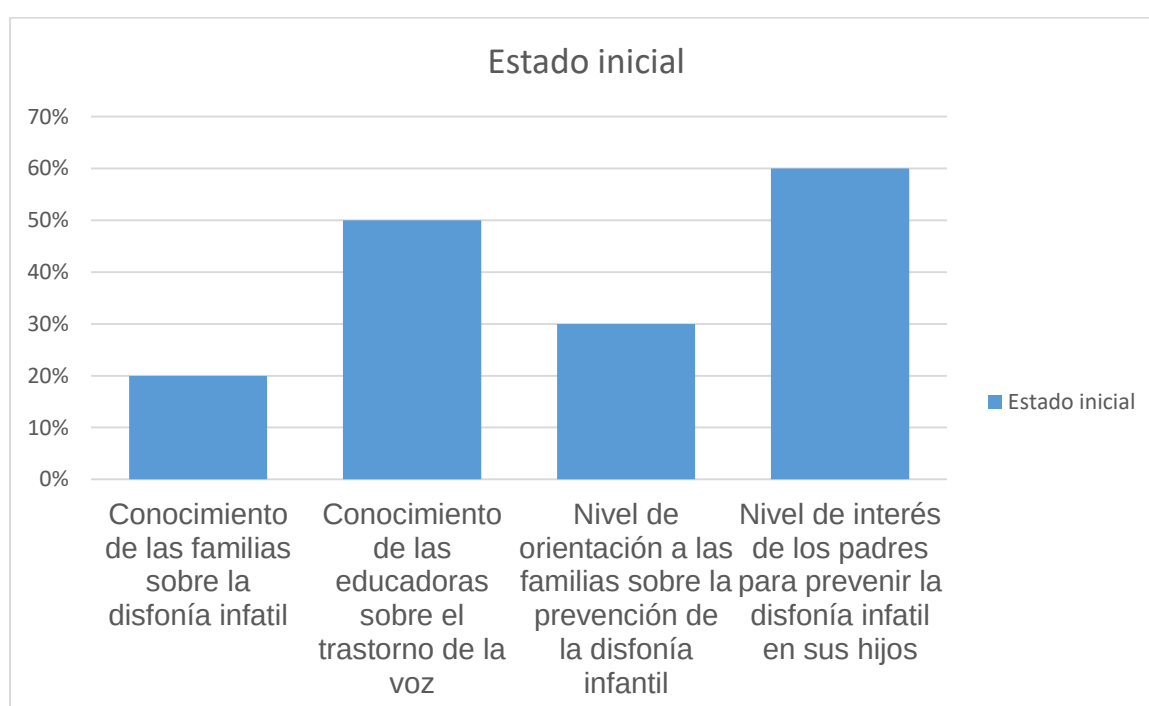
Exploración logopédica (Anexo#4)

El estado de la expresión oral del lenguaje de los menores analizados es adecuado, su vocabulario es amplio y no se aprecian alteraciones anatómicas. La audición impresiona normal ante los estímulos sonoros. Todos presentan un lenguaje acorde con su edad cronológica. En el análisis de la pronunciación tres de ellos distorsionan el fonema /r/, lo cual no es considerado un trastorno en la edad que poseen, pues están en plena formación del lenguaje. En cuanto a las cualidades de la voz, son menores que gritan constantemente, forman perretas aguzando de su voz, algunos tienen un tono de voz alto, son niños hiperactivos, dos de ellos presentan cuadros ORL, otitis y faringitis.

Encuesta a los familiares (Anexo#5)

La encuesta se realizó de forma anónima con el objetivo que las familias marcaran con honestidad su criterio sobre el tema de investigación. Con su aplicación se pudo detectar que la mayoría no tiene en cuenta los cambios en la voz de sus hijos, la mayoría desconocen sobre la disfonía infantil y cómo prevenirla. Todos consideran necesario recibir orientaciones sobre el tema.

El siguiente gráfico recoge los resultados de los instrumentos aplicados según los descriptores de medida: medio, bajo y muy bajo.



20% - Muy bajo

30% - Bajo

50%- 70% - Medio

Una vez concluida la aplicación de métodos empíricos para el diagnóstico y o determinación de necesidades, se constatan las siguientes:

Fortalezas:	Debilidades:
Existe preocupación por las necesidades del niño.	Las familias desconocen cómo prevenir los trastornos de la voz.
Se constata motivación por la adquisición de conocimientos acerca de los trastornos de la voz.	Se aprecia un uso incorrecto de la voz y patrones lingüísticos incorrectos en el hogar, el círculo infantil y la comunidad.
Manifiestan disposición para la ejecución de actividades para la prevención de la disfonía infantil.	La mayoría de los docentes desconocen el tema científicamente y poseen escasa bibliografía acerca de la disfonía infantil en el círculo infantil.

Las fortalezas y debilidades identificadas facilitaron la proyección del manual de orientación familiar para la prevención de la disfonía infantil.

2.3 Presentación de la propuesta. Características y estructura

El análisis bibliográfico realizado por la autora y los resultados de los diferentes instrumentos aplicados permitieron que se proponga como posible solución al problema de investigación un manual de orientación familiar para prevenir las disfonías infantiles. que se sustenta a partir de sus fundamentos.

Considera la concepción marxista leninista y martiana de la educación, como las leyes más generales que rigen el desarrollo, las categorías filosóficas y el fundamento metodológico, para abarcar en su totalidad y profundidad las interrelaciones y

conexiones entre los objetos y fenómenos del contexto educativo y la lógica para operar con los métodos científicos particulares, en el conocimiento de la realidad educativa familiar ya que en la concepción de orientación a la familia se aprecia un condicionamiento histórico social que se expresa en su surgimiento y evolución, que destaca el papel del hombre como producto y productor de la cultura.

Es por ello que la familia representa uno de los principales logros de las relaciones entre hombres y mujeres en la historia de la humanidad, que aparece en una pluralidad de tipos y formas, diversos en cuanto a su estructura y funcionamiento, en cuyo interior se produce un continuo intercambio con el medio circundante. Este intercambio propicia la mediación del maestro logopeda en la orientación a la familia para el cumplimiento de sus funciones.

Se considera a la familia como la célula fundamental de la sociedad, primera y continua fuente de influencias educativas en el niño, susceptible de la influencia educativa como un fenómeno social, cuya función, contenido y esencia se revela en la práctica educativa. A través de las relaciones que genera durante el desempeño de sus funciones profesionales el maestro logopeda, parte de considerar que las cualidades psíquicas del hombre, se desarrollan en la actividad, al igual que las de la familia.

Se reconocen los postulados de la escuela Histórico Cultural, (Lev Semyonovich Vygotsky y sus seguidores) a que los mismos constituyen una guía para emprender el análisis del valor de la interacción social, así como el papel de la orientación como mediación en el desarrollo de los procesos cognitivos, procedimentales y actitudinales de la familia y su participación activa en el proceso de prevención de disfonías infantiles, pues se considera que la enseñanza es promotora del desarrollo y su articulación con los períodos evolutivos, en los cuales tiene un impacto especial el conjunto de influencias que actúa sobre los niños, el desarrollo psicológico del hombre como resultado de la acción del medio, es mediatizado por la vivencia.

Por lo que en la propuesta se consideran los principios de la enseñanza, el carácter educativo de la misma expresado en la unidad de la instrucción y la educación, se concibe el desarrollo de conocimientos, y de habilidades, hábitos y valores de la personalidad direccionado hacia una vida feliz, sana y virtuosa transversada por la educabilidad de sus infantes. En el sistema se concretan las interrelaciones dinámicas

de las leyes, contradicciones, principios, categorías, eslabones, etapas, componentes y funciones didácticas que rigen el proceso pedagógico, así las adecuaciones necesarias para la atención a las diferencias individuales a través de actividades que permiten la activa participación familiar.

El proceso educativo constituye un amplio sistema, compuesto por subprocesos organizados, estructurados e interrelacionados a través de estrechos vínculos y en el que se establecen relaciones entre los agentes educativos para alcanzar los propósitos trazados. El círculo infantil no puede sustituir la función educativa de la familia, pero tiene el encargo social de organizar, planificar y dirigir científicamente el proceso de orientación familiar.

Ante lo expuesto se revela: **La propuesta de un manual de orientación familiar para la prevención de la disfonía infantil.**

Se considera una forma de aproximación y representación de la realidad y al mismo tiempo una orientación hacia la práctica científica diferente, como paradigma científico. Es un modelo de carácter general que alude a características muy generales compartidas con un gran número de entidades y de diferentes descripciones.

En este sentido es conveniente analizar el significado de la palabra manual, en el Diccionario Básico de la Lengua Española (2020), se define como "...libro en el que se compendia lo más sustancial de una materia." Según la revista Caribeña de Ciencias Sociales (2016), los manuales nos permiten comprender mejor el funcionamiento de algo, o acceder, de manera ordenada y concisa, al conocimiento algún tema o materia.

Un manual es un instrumento que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática, información sobre objetivos, políticas, atribuciones, procedimientos; así como instrucciones o acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución de una tarea, teniendo como marco de referencia los objetivos en dependencia de la función que le corresponda cumplir. Existen diferentes tipos de manuales, utilizados por instituciones o centros.

El principal propósito del manual es preparar y entrenar a familia y otras personas del barrio que participan directa e indirectamente en la educación de los niños de

preescolar, para que puedan contribuir, de forma conjunta con la escuela y la comunidad, a la prevención de los trastornos del lenguaje.

El manual se fundamenta en la concepción dialéctico-materialista, por la relación que se establece entre los principios, leyes y categorías filosóficas, que permitieron a la autora un acercamiento objetivo a los procesos investigados, a partir del diagnóstico de los sujetos implicados. Se asume el enfoque histórico-cultural de Vygotsky, debido a que el preescolar atraviesa etapas y leyes del desarrollo.

El carácter educativo de la enseñanza que expresa la unidad de lo instructivo y lo educativo se aprecia al orientar a la familia para que comprenda y concientice su papel en este proceso, con ayuda del manual. Igualmente se pone de manifiesto el principio de la asequibilidad debido a que en el manual las orientaciones que se emiten tuvieron en cuenta el diagnóstico realizado a las familias, sus principales fortalezas y debilidades, todo lo cual permitió que se ajustaran a sus necesidades y potencialidades.

A su vez se evidencia que los procesos de órdenes biológicos, psicológicos e histórico-sociales condicionan el pensamiento, logrando una actividad productiva que determinará las transformaciones en el desarrollo de los niños y propiciará en ellos el alcance de la zona de desarrollo próximo. Se enfatiza en la necesidad de la formación de la personalidad mediante el enfoque histórico cultural, a partir del diagnóstico y la estimulación del desarrollo mediante la categoría vivencias, que promueve el maestro logopeda y otros agentes educativos.

La propuesta es un manual educativo de orientación familiar para brindar consejos y ayuda logopédica y psicopedagógica a los padres. Les sirve de guía a las educadoras del círculo infantil, para prevenir los trastornos de la voz, brindándoles conocimientos sobre el cuidado de la voz, la higiene vocal y la importancia de estar al tanto de los cambios que existen en sus niños. Es de utilidad para las escuelas, ya que se ubicará como bibliografía a consultar por todas las familias, la comunidad y las escuelas de padres.

2.3.1 Estructura del manual

El manual de orientación familiar para la prevención de la disfonía infantil consta de 15 páginas distribuidas en carátula, índice, presentación, desarrollo, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. En la introducción se expresa la importancia del

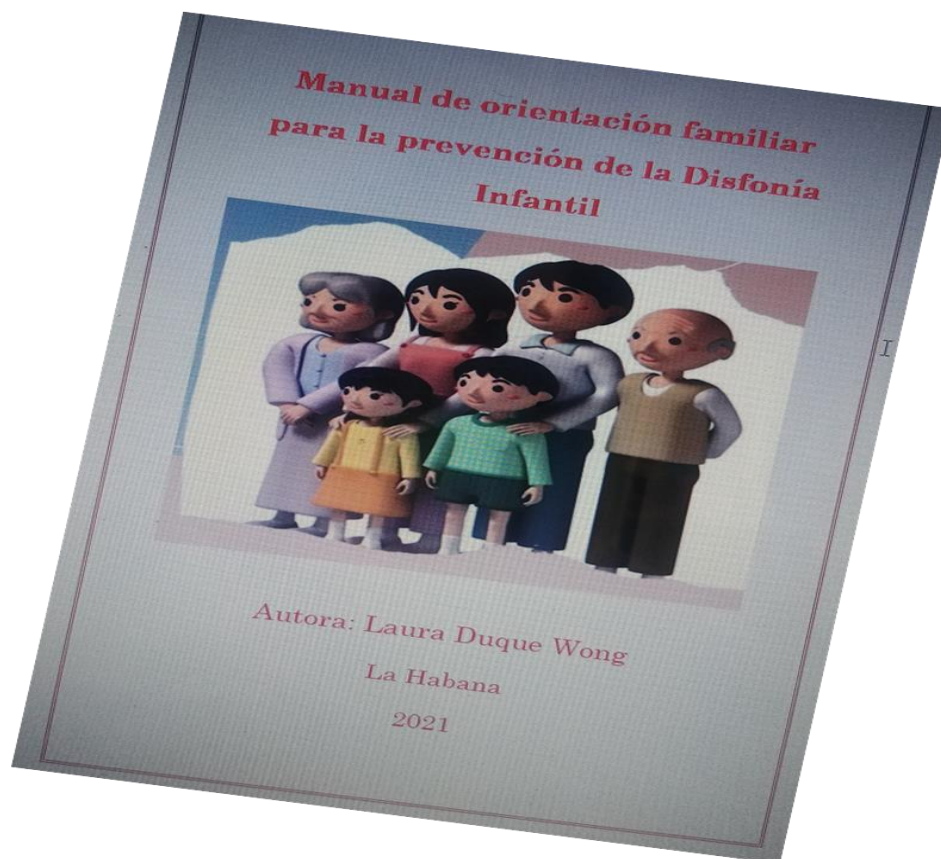
manual y su objetivo principal. El desarrollo posee diferentes temáticas 1- Importancia de la prevención, 2- Hablemos sobre los trastornos de la voz, 3- Síntomas de alerta en la voz de nuestros niños, 4- Orientaciones a la familia. Se puntualizan aspectos esenciales para un correcto desarrollo en los niños con las herramientas y las influencias que reciba de su familia.(Anexo#8)

El desarrollo aborda el significado de prevención, aspectos sobre la disfonía infantil, sus características, síntomas de alerta, así como las orientaciones para que la familia adopte medidas para prevenir los trastornos de la voz. Resalta el adecuado comportamiento que deben tener los familiares frente a los niños y las formas correctas de hablar. También destaca el trabajo conjunto entre la familia, la escuela y la comunidad. Posteriormente mediante las conclusiones se refleja la importancia del hábito de lectura, pues es el método más eficaz de prevención. En las recomendaciones aparecen una serie de consejos para el cuidado de la voz y la prevención de algún trastorno.

El manual estará disponible en el círculo infantil “Los Habaneritos” del municipio de Bejucal, provincia Mayabeque, asequible a todos los familiares. Las maestras del círculo y la logopeda son las encargadas de divulgarlo en las orientaciones a los padres para esclarecer las dudas existentes sobre el tema. También se encuentra en la escuela primaria Viet Nam Heroico, siendo de gran utilidad para la directora y maestras a la hora de realizar las reuniones de padres y las preparaciones metodológicas.

El manual para la logopeda será un recurso de apoyo necesario a la hora de trabajar con estos trastornos de la voz, o para realizar acciones profilácticas. La comunidad también empleará el manual en sus actividades, donde deberán tener en cuenta:

- ✓ No realizar esfuerzos vocales como gritos.
- ✓ Divulgar que no se debe hablar sobre ruidos ambientales o musicales.
- ✓ Evitar ambientes contaminados por presencia de polvo o humo.
- ✓ Promover una adecuada higiene bucal y nasal.



El manual se concibe como una bibliografía y una estrategia de orientación para las familias, las educadoras y la comunidad. Mediante su divulgación se ampliarán los conocimientos sobre la importancia de la función de la familia y la prevención de los trastornos de la voz.

2.4 Valoración de la propuesta

El proceso de valoración del manual de orientación familiar para la prevención de la disfonía infantil se realizó mediante la consulta a especialistas. (Anexo#9)

Para la consulta a especialistas se requirió la emisión del juicio valorativo de un grupo de 6 especialistas, todos de reconocido prestigio y calidad en su desempeño profesional. La selección se desarrolló de forma intencional. Dicho grupo estuvo compuesto por 2 doctores, 2 másteres y 2 licenciados de entre 7 y 30 años de experiencia. Se tuvo en cuenta que cumplieran los siguientes requisitos:

- ✓ Ser licenciado, máster o doctor en ciencias pedagógicas.
- ✓ Ser graduado de Licenciatura en Educación Logopedia y Educación Preescolar con más de 5 años de experiencia.

A todos se les entregó un cuestionario con una escala valorativa, dónde tenían que evaluar:

- ✓ Fundamentación del manual.
- ✓ Ajuste a las necesidades y particularidades de los niños y las familias
- ✓ Estructura y contenido.
- ✓ Calidad de las orientaciones a las familias.

Los resultados fueron los siguientes:

- Relacionado con la fundamentación, el 60 % de los especialistas consideró muy adecuada y el 40 % adecuada los cuales plantearon que se tiene en cuenta la lógica del proceso.
- El 100% consideró la propuesta muy adecuada pues se ajusta a las necesidades de los niños y sus familias.
- Sobre la estructura y contenido del manual el 70% de los especialistas la evaluó de muy adecuada como vía para la prevención de los trastornos de la voz, en particular de la disfonía infantil y el otro 30% adecuada.
- El 50% la evaluó de muy adecuada y el otro 50% de adecuada pues el manual brinda información necesaria para las familias y las educadoras del círculo infantil.

Como sugerencia propusieron la ampliación de las orientaciones en cuanto a los trastornos de la voz. La valoración realizada por los especialistas permite mejorar la propuesta, su aplicabilidad y posible efectividad.

Conclusiones

A partir de la sistematización de los referentes teórico-metodológicos relacionados con la orientación familiar para la prevención de los trastornos de la voz, se pudo concluir lo siguiente:

1. El estudio de los referentes teórico-metodológicos que sustentan la orientación familiar para la prevención de la disfonía infantil permitió caracterizar los fundamentos, demostrando la importancia de la preparación de las familias para su participación en la prevención de los trastornos de la voz.
2. En la caracterización del estado inicial de la orientación a la familia para prevenir la disfonía infantil de sus hijos que asisten al círculo infantil “Los Habaneritos” del municipio de Bejucal, de la provincia Mayabeque, se pudo constatar que existía desinformación sobre el tema y las familias, al igual que las educadoras, no utilizaban correctamente la voz.
3. El manual de orientación familiar para la prevención de la disfonía infantil constituye una herramienta para ampliar los conocimientos sobre el tema y adoptar medidas y acciones para evitar que sus niños presenten este trastorno de la voz. Mediante los ejercicios que se plantean la familia puede realizar en forma de juego actividades de manera profilácticas para lograr un correcto desarrollo. Las educadoras en el círculo también pueden tener en cuenta estas medidas y seguir las recomendaciones para una vida más sana.
4. La valoración de la propuesta por consulta a especialistas permitieron mejorar la misma para su aplicación en la práctica pedagógica y para su divulgación en diferentes contextos.

Recomendaciones

- ✓ Continuar el estudio sobre los contenidos teóricos-metodológicos relacionados con la orientación familiar para la prevención de la disfonía infantil.
- ✓ Divulgar la propuesta en eventos científicos y otros espacios de intercambio y socialización.
- ✓ Aplicar la investigación y la propuesta en la práctica docente.
- ✓ Diseñar el manual en una aplicación móvil.

Bibliografía

Castro A., P. L. (1996). Como la familia cumple su función educativa. La Habana: Pueblo y Educación

Bustos (1999) Trastornos de la voz en edad escolar. Aljibe, Málaga

Bustos, I. (2000). Trastornos de la voz en edad escolar. Málaga: Aljibe.

CELAEE., 2. F. (2001). La exploración logopédica. Material de la Maestría en Educación Especial. La Habana.

Perea, B. T. (2002) La educación familiar. La Habana: Ed. Pueblo y Educación

Arés, P. (2002). Psicología de Familia. Una aproximación a su estudio. La Habana: Editorial Félix Varela

González, T. M, (2003) Familia, unidad y diversidad, La Habana, Cuba, Editorial Pueblo y Educación

Benítez, M. E. (2003). La familia cubana en la segunda mitad del siglo XX. La Habana: Editorial Ciencias Sociales

Gervilla, E. (2003). Educación Familiar. Nuevas relaciones humanas. Madrid: Editorial Narcea.

Franco G, O. (2004). Lecturas para educadores preescolares. La Habana: Editorial Pueblo y Educación

Torres, M. (2004). Familia y diversidad. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Vázquez, R. (2004). La familia. Aspectos sociales, culturales, económicos, históricos, políticos y legales. Obtenido de Vía Internet [http:// www.monografías.com](http://www.monografías.com).

Martínez, C. (2005). Para que la familia funcione bien. La Habana: Editorial Científico Técnica.

Morales, M. (2005). Enfoque práctico de la Logopedia. La Habana, Cuba, Editorial Academia de Ciencias.

Ríos, I. (2006) Fundamentos pedagógicos de la educación en la primera infancia. Tesis doctoral. UCPEJV. La Habana.

Álvarez, L. (2008) Logopedia y Foniatría. La Habana: Editorial Ciencias Médicas.

Rodríguez R, A. C. (2009). Prevención y Educación Preescolar. Selección de lecturas. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Puyuelo, M. (2009). Disfonías infantiles. Talleres para la prevención. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 29(4), 271.

Puyuelo, M. (2009). La logopedia en la escuela. Propuestas desde la práctica para una educación más inclusiva. Revista de Logopedia. Foniatría y Audiología, 29(4), 271

Miranda, S. V. (julio 2010). Intervenciones indirectas y directas con alumnos con alteraciones de la voz. Artículo no 32.

Torres, M. V. (2010) Intervención indirecta y directa con alumnos con alteraciones de la voz, Antequera, Málaga

Jiménez, F. (2010) La comunidad y su entorno. Argentina, Editorial Paidós

Fernández, G. Y. (2011). La organización de la atención logopédica integral en las instituciones educativas. Folleto de preparación para el maestro logopeda

FiuzaAsorey, M. (2011). Una realidad olvidada: la salud vocal en Educación Infantil y Primaria. La Habana.

Pilar, M. R. (2012) La escuela de Educación General. Perspectivas y Proyecciones. La Habana.

CELEP (2014) La Educación Preescolar en Cuba. Antecedentes, Actualidad y Perspectivas en la Atención Educativa a la Primera Infancia, La Habana, Cuba

García, R. A. (2015) "Como educar a los hijos sin equivocarse tanto" La Habana, Editorial José Martí.

Veranes, T. O. (2018) Caracterización de la orientación familiar en la Educación Especial, una mirada desde su historia en Cuba, Santiago de Cuba, Cuba

Arrondo, H. D. (2018) La orientación familiar en la corrección de la dislalia mediante la tarea para la casa, La Habana

[https://www.trabajocomunitario- CubaEduca.com](https://www.trabajocomunitario-CubaEduca.com)

<https://www.youtube.com/watch>

<https://youtu.be/g6zaadbD-0M>

<https://otoneurologico.com>

<https://www.bebesymas.com>

<https://www.logopediadomicilio.es>

Anexos

Anexo # 1

Guía de observación

Objetivo: Analizar el comportamiento de los niños en los diferentes contextos (familiar, escolar y comunitario) y el estado de su lenguaje.

Aspectos:

- Situación del lenguaje oral y el vocabulario
- Patrones lingüísticos a imitar
- Trastornos de la pronunciación
- Comportamiento de los niños a la hora del juego
- Comunicación con adultos y coetáneos
- Relación con padres y educadoras
- Uso de la voz de los niños durante las actividades del día
- Estado y uso de la voz de las educadoras y los familiares

Se visitarán las actividades programadas que realicen en el círculo infantil, al igual que los horarios de juegos. Se observará el comportamiento de los familiares dentro y fuera del círculo. Se analizará la forma de actuar y de expresarse de las educadoras en todas las situaciones del día. Utilización de la bibliografía.

Anexo # 2

Guía de Entrevista a la Familia:

Objetivo: Conocer su preparación acerca de los trastornos de la voz.

- 1- ¿Conoce sobre los trastornos de la voz?
- 2- ¿Qué es la disfonía infantil?
- 3- ¿Ha recibido orientaciones del círculo infantil sobre los trastornos de la voz?
- 4- ¿Le han hablado sobre la importancia del correcto uso de la voz y sus posibles trastornos en los niños?
- 5- ¿Conocen medidas para prevenir que surjan los trastornos de la voz?
- 6- ¿Cree que usted realiza un correcto uso de la voz?
- 7- ¿En qué estado usted considera que esta su voz?
- 8- ¿Ha leído algún documento, bibliografía como folleto, internet, manual, libros acerca de la disfonía?
- 9- Siente satisfacción al recibir orientaciones por parte del médico de la familia.
- 10- Pudiera darme otras sugerencias.

Muchas Gracias.

Anexo # 3

Guía de entrevista a los docentes y directivo:

Objetivo: Investigar si tienen dominio de los trastornos de la voz, su prevención y orientación a las familias.

- 1- ¿Conoce algún trastorno de la voz?
- 2- ¿Qué es la disfonía infantil?
- 3- ¿Cómo pueden evitar que sus niños padezcan este trastorno de la voz?
- 4- ¿Qué orientaciones les brindan a las familias sobre los trastornos de la voz?
- 5- ¿Han tenido niños con síntomas de alerta que puedan presentar estos trastornos, qué medidas han adoptado?
- 6- ¿Tienen bibliografías en el círculo sobre la educación de la voz?
- 7- ¿Ha leído documentos, artículos en internet o folletos sobre los trastornos de la voz y su cuidado?
- 8- Pudiera brindarme otras sugerencias.

Muchas Gracias.

Anexo # 4

Objetivo de la aplicación de la Hoja de exploración del lenguaje: Conocer los antecedentes del desarrollo del niño, estado de la audición, del lenguaje y de su voz.

HOJA DE EXPLORACIÓN DEL LENGUAJE

Centro

Nombres y apellidos

Expediente CDO

Fecha de nacimiento

Edad

Sexo

Grado

Procedencia del niño

Motivo de consulta

Datos concretos sobre la evolución del lenguaje

Otros datos de interés

Examen específico del habla. Estado del aparato articulatorio

Características de la audición

Estado de la expresión oral. Conversación espontánea. Características

Vocabulario (volumen, calidad, significado)

Estructura gramatical (análisis de las características morfológicas)

Análisis de la pronunciación y de los procesos fonemáticos

Observaciones

Ritmo y fluidez del Lenguaje

Características de la voz

Examen de la lectura y escritura

Escritura

Conducta observada durante la prueba

Anexo # 5

Encuesta a los familiares:

Objetivo: Conocer la opinión acerca del tema de investigación.

Cuestionario

Estimado Familiar, necesitamos de su apoyo para responder con sinceridad las siguientes interrogantes, con el objetivo de conocer su opinión acerca de la orientación familiar para la prevención de la disfonía infantil

1- Considera importante prevenir los trastornos de la voz:

☐ sí ☐ no

2- Conoce que es la Disfonía Infantil:

☐ sí ☐ no

3- Usted realiza un correcto uso de la voz:

☐ sí ☐ no ☐ a veces ☐ casi nunca

4- Conoce que medidas podemos adoptar para prevenir los trastornos de la voz:

☐ sí, tengo conocimientos sobre el tema

☐ no, nunca le he dado importancia al tema

5- Ha notado cambios en la voz de su hijo/a:

☐ sí ☐ no ☐ a veces ☐ solo cuando grita mucho ☐ cuando está enferma/o
☐ nivel alto de la voz ☐ Niveles bajos de voz

6- ¿Cómo considera el estado de su voz?

☐ adecuado ☐ poco adecuado ☐ bajo ☐ medio

7- Cree que es importante recibir orientaciones sobre cómo prevenir los trastornos de la voz:

__sí __ a veces __no __ lo considero adecuado

8- Pudiera sugerirme alguna otra opinión sobre el tema:

Muchas gracias por su colaboración.

Anexo # 6

El análisis documental se realizó al revisar los siguientes documentos:

- Libros relacionados con la orientación familiar.
- Libretas de actividades de los niños.
- Exploraciones logopédicas.
- Expedientes psicopedagógicos.
- Libro de Anatomía y fisiología de la voz.

Aspectos a considerar en el análisis:

- Presencia de los indicadores relacionados con la prevención de los trastornos de la voz en la primera infancia.
- Estado actual y antecedentes del comportamiento de los niños, al igual que su desarrollo.
- Preparación de las educadoras y la familia sobre el tema.
- La bibliografía que consta en el contexto educativo sobre el tema.

Anexo #7

Entrevista a la promotora del Programa Educa tu Hijo:

Objetivo: Conocer su preparación acerca de los trastornos de la voz, su prevención y orientación a las familias.

- 1- ¿Qué orientaciones les brinda a las familias?
- 2- ¿Cada que tiempo se reúnen?
- 3- ¿Ha impartido orientaciones sobre los trastornos de la voz?
- 4- ¿Ha trabajado con familias que presenten algún trastorno de la voz?
- 5- ¿Cuál es la situación de estas familias del círculo infantil “Los Habaneritos”?
- 6- ¿Considera que estas familias son potenciadoras del desarrollo de sus hijos?
- 7- Pudiera brindarme alguna sugerencia del tema que ha evidenciado en su desempeño profesional que sea de interés para orientar a la familia.

Muchas Gracias.

Manual de orientación familiar para la prevención de la Disfonía Infantil



Autora: Laura Duque Wong

La Habana 2021

Índice:

Presentación	pág. 1
¿Qué conocemos sobre la Prevención?	pág. 2
Hablemos sobre los trastornos de la voz	pág. 4
La Disfonía Infantil. Síntomas de alerta	pág. 6
Orientaciones a la familia	pág. 7
Nota	pág. 11

Recomendaciones pág. 12

Bibliografía pág. 13

Queridos Familiares:

El siguiente manual les explicará lo relacionado con la voz y la prevención de los trastornos que se derivan de su mal uso. Se destaca la labor de la familia en la orientación, guía y enseñanza que favorece la crianza, por lo que es de vital importancia conocer:

¿Qué es la prevención?

¿Cuáles son los Trastornos de la voz?

Qué conocemos por Disfonía Infantil?

La importancia de la higiene vocal

¿Qué medidas podemos adoptar para el cuidado de la voz?



¿Sabías que...?

La prevención es un término tan universal que es aplicable a cualquier esfera de la sociedad, la naturaleza y la salud...



Si usted como familia garantiza influencias educativas con experiencias positivas en el entorno escolar, familiar y comunitario que pueda producir cambios en su niño; está realizando **un trabajo preventivo**.



IMPORTANTE

La etapa preescolar es de suma importancia para el desarrollo del niño, en este tiempo inicia la formación de su personalidad.

Todo lo que se logre con amor, paciencia y persistencia durante esta etapa, será esencial para su vida futura. Sin duda es la etapa más importante, donde ustedes como familia, los vecinos y la escuela juegan un papel único en su desarrollo y bienestar.



Debe **dedicarle tiempo**, jugar, **conversar**, tratarlo con **cariño** y crear un ambiente de **confianza** entre ustedes; así la relación padre e hijo/a o madre e hijo/a, será más unida y podrán **vivir en armonía**.

Hablemos sobre los trastornos de la voz

**La voz es el fondo musical de las palabras
que traduce los sentimientos.**

Debe saber... Que un trastorno de la voz es toda alteración que afecte su tono, timbre e intensidad.

Peroooo... sabía que existen dos tipos de trastornos de la voz:

1- Cuando una persona sufre la pérdida total de la voz, por un accidente, trauma o enfermedad, se dice que se encuentra- Afónico y presenta el trastorno de la voz denominado: **Afonía**.

2- Cuando nos quedamos roncos o nos cambia la entonación de la voz, por su mal uso, abuso o enfermedad, se dice que estamos – Disfónicos y presentamos el trastorno de la voz denominado: **Disfonía**.

¡TOME NOTA!

Si los cambios de la voz son persistentes por más de 21 días debe acudir al médico.

Son diversas las causas que provocan un trastorno de la voz:

- ✚ Mal uso de la respiración.
- ✚ Alteraciones de la audición.
- ✚ Incorrecto uso de la voz, por ejemplo,
 - Hablar en voz alta, dando gritos.
 - No realizar reposo de voz cuando estamos roncos.
 - Hacer sonidos constantes con la garganta, lo que nos afecta las cuerdas vocales.
- ✚ Cambios bruscos de temperaturas.

✚ Presencia de nódulos en las cuerdas vocales.

✚ Realizar sobreesfuerzo y abuso de la voz.

CURIOSIDAD

¿Sabía que el sonero cubano Cándido Fabré desde pequeño presenta una Disfonía, debido a su constante ronquera, que con los años se ha vuelto crónica?

Durante una entrevista mencionó que improvisa porque su voz no es potente, es espontáneo y la disfonía siempre lo acompaña.



Entre las disfonías existe, la Disfonía infantil.

Si su niño:

- Es hiperactivo.
- Tiene familiares ansiosos.
- La comunicación es por medio de gritos.
- Tiene tendencia a presentar cuadros de otitis, faringitis.
- Presenta deficiencias auditivas.
- Tiene la voz ronca, áspera.
- Realiza llantos intensos.

- Tiende a la rigidez en el cuello.
- Habla muy rápido sin consumir aire hasta quedarse sin aliento.
- Produce chillidos incontrolados.

Está en presencia de **síntomas de alerta** ante una disfonía, por lo que requiere orientaciones y un trabajo preventivo para evitar que estos síntomas se conviertan en algo más grave.



¿Sabías que...?

En cuanto al sexo la relación sería una niña por cada tres niños, siendo el pico de incidencia entre los 5 y los 10 años de edad aproximadamente.

Generalmente estos trastornos no son severos y no suelen suponer la pérdida completa de la voz de manera prolongada o permanente.



Familia es importante conocer los cambios que se producen en sus niños. Siempre deben actuar a tiempo ante problemas o dificultades; además de tomar medidas para prevenir que aumenten en gravedad.



Existen algunas **orientaciones encaminadas fundamentalmente a prevenir** y reducir las **conductas abusivas de la voz**, éstas pueden ser de gran utilidad si contamos con **su ayuda en los hogares**:

- ✚ No realizar esfuerzos vocales como gritos, llamados a voces durante el juego o el deporte, hablar sobre ruidos ambientales o musicales.
- ✚ Evitar ambientes contaminados por presencia de polvo, humo, cambios de temperaturas o condiciones atmosféricas desfavorables.
- ✚ No utilizar la voz durante procesos inflamatorios agudos del aparato fonador.
- ✚ Eliminar el hábito de toser y aclarar excesivamente la garganta pues eso resulta irritante.
- ✚ El sueño como manifestación de reposo debe siempre respetarse, durmiendo de 6 a 8 horas

y evitar el uso vocal en las primeras horas de levantarse.

Debe saber... que el niño imitará constantemente a sus familiares más cercanos, de ahí la importancia de mantener una figura correcta delante de él, no deben hablar palabras inapropiadas, ni hacer gestos vulgares en su presencia, el lenguaje debe ser fluido y despacio, con un tono de voz moderado.



Realice actividades como la Logopeda en el hogar:

Se puede convertir en logopeda y realizar diversos ejercicios en forma de juego:

- ✚ Ejercicios de respiración. Inspiración y espiración nasal y bucal, con o sin retención de aire. Tomamos el aire según subimos los brazos y lo expulsamos cuando los bajamos lentamente.**
- ✚ Imitar la acción de inflar globos.**

✚ Imitar muecas delante del espejo, abriendo y cerrando la boca, moviendo la lengua hacia diferentes direcciones, inflar las mejillas.

✚ Decir las vocales con tiempo medio, lento y rápido.

✚ Caminar rápido emitiendo un sonido prolongado.

✚ Emitir vocales alargando el sonido desde el cuchicheo hasta una intensidad media y luego alta: caminando rápido, corriendo, saltando, bailando.

✚ Subir y bajar escaleras de manera lenta, rápida, detenerse y decir una frase, puede coincidir con las actividades que esté trabajando en el círculo.

✚ Trotar rápido emitiendo un sonido prolongado, luego frases.

✚ Reproducir ritmos y sonidos, pueden reproducir palmadas.

✚ Simular ecos. Emitir la voz en volumen bajo simulando ecos con palabras y frases cortas.

✚ Cuchicheo intenso y extenso. Repetir frases cortas y sencillas de manera cuchicheada, como en secreto marcando bien la articulación y abriendo ampliamente la boca

✚ Masticación sonora verbal. Imitando los movimientos naturales de comer, contar números, decir palabras, de forma exagerada.

Al terminar puede premiarlo cuando lo haga correctamente, díglele que lo ha realizado **MUY BIEN...**



En el caso que se equivoque no lo critique, ni lo ofenda,
repitan la actividad o realicen otra.



Nota:

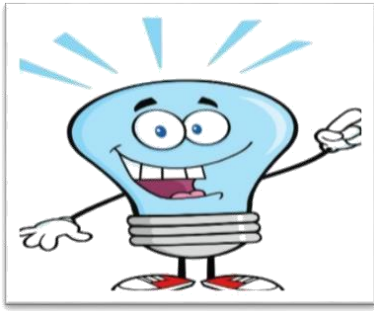


Recuerde que usted es el que construye las bases para que su hijo/a sea una buena persona en el futuro. Siempre debe velar por satisfacer sus necesidades, recibiendo orientaciones de las instituciones educativas y realizando una labor preventiva ante los trastornos, por lo que debe ampliar sus conocimientos mediante la lectura, pues este constituye el método más eficaz.

Le Recomendamos:

Mantener un correcto cuidado de la higiene vocal, para ello es necesario:

- Comer alimentos que contengan vitaminas A, B, E, D y C.
- No beber líquidos muy fríos o calientes, perjudican tanto unos como los otros. Se deberá acostumbrar a los niños/as a tomar bebidas naturales.
- Mantener la cabeza y los pies secos: los enfriamientos son provocados, en muchos casos, por dichas causas.
- No comer excesivos picantes, pueden aparecer flemas.
- Tener cuidado con el aire acondicionado, afecta las mucosas.
- Tener cuidado con la inhalación de los olores fuertes, productos de limpieza, pinturas, etc. Éstos irritan las mucosas del aparato respiratorio.
- Beber agua durante la exposición de la voz, disponiendo de una botella a tu alcance. Es importante crear éste hábito en los niños/as.
- Recuperar el aliento con regularidad cuando se está hablando.



Muchas Gracias

Bibliografía

Pueden consultar otros documentos importantes como:

- ✓ Para que la familia funcione bien. La Habana: Editorial Científico Técnica.
- ✓ Prevención y Educación Preescolar. Selección de lecturas. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- ✓ Una realidad olvidada: la salud vocal en Educación Infantil y Primaria.
“Como educar a los hijos sin equivocarse tanto” La Habana, Editorial José Martí.
- ✓ La comunidad y su entorno. Argentina, Editorial Paidós.
- ✓ Disfonías infantiles. Talleres para la prevención. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología.

Anexo #9

Consulta a especialistas.

Estimado especialista:

Se le solicita hacer un manual de orientación familiar para la prevención de la disfonía infantil en el círculo infantil “Los Habaneritos” del municipio de Bejucal, Mayabeque. De antemano se le agradece su colaboración.

Datos generales:

-Nombre y Apellidos:

-Años de experiencia laboral:

-Centro de trabajo:

-Labor que desempeña:

Marque en una escala de 4 categorías cuán adecuado considera cada aspecto de la propuesta. Las categorías son: Muy adecuado, Adecuado, Poco Adecuado, Inadecuado.

Aspectos a valorar	M.A	A	P.A	I
1. Fundamentación del manual	4	2		
2. Ajuste a las necesidades y particularidades de los niños y las familias	6			
3. Estructura y contenido	5	1		
4. Calidad de las orientaciones a las familias	3	3		

Sugerencias y/o recomendaciones para el perfeccionamiento de la propuesta:

Anexo #10

